



12 Eselsbrücken fürs Pflegeexamen

Pflegeprozess, PESR, SMART, ATL, AEDL und mehr – die wichtigsten Pflege-Schemata kompakt auf den Punkt gebracht. Ausdrucken und an den Lernplatz hängen.

Bestehen ist planbar.

Pflegeplanung

Pflegeziele

ATL / AEDL

Notfall

Hygiene

12

Eselsbrücken

A4

druckfertig

100%

kostenlos

INHALT

1 Pflegeprozess

3 SMART

5 13 AEDL

7 Prophylaxen

9 ... und 4 weitere

2 PESR

4 12 ATL

6 10-R-Regel

8 Dekubitus

△ Lernhilfe für Ausbildung und Prüfung, ersetzt kein Lehrbuch. Es gelten deine Lehrinhalte und die Standards deiner Einrichtung.

Die 12 Eselsbrücken

Jede Karte: Schema, Erklärung, Merksatz.

01 Pflegeprozess

Der 6-stufige Regelkreis nach Fiechter & Meier

- 1** Informationen sammeln – Anamnese, Assessment
- 2** Probleme und Ressourcen erkennen
- 3** Pflegeziele festlegen – realistisch, überprüfbar
- 4** Maßnahmen planen – wer, was, wann, wie oft
- 5** Maßnahmen durchführen
- 6** Evaluation – Ziel erreicht? Plan anpassen

Merke: Ressourcen immer ausdrücklich dokumentieren.

02 PESR

Pflegeproblem richtig formulieren

- P** Problem – das pflegerische Problem benennen
- E** Einflussfaktoren – Ursache („bedingt durch“)
- S** Symptome – woran erkennbar („zeigt sich durch“)
- R** Ressourcen – was kann der Mensch noch selbst?

Merke: Problem + Ursache + Symptom + Ressource.

03 SMART

Pflegeziele, die im Examen zählen

- S** Spezifisch – konkret und eindeutig
- M** Messbar – woran erkennt man den Erfolg?
- A** Attraktiv / akzeptiert – vom Patienten mitgetragen
- R** Realistisch – mit den Ressourcen erreichbar
- T** Terminiert – mit klarem Zeitrahmen

Merke: Ein Ziel beschreibt den Zustand des Patienten, nicht deine Tätigkeit.

04 12 ATL

Aktivitäten des täglichen Lebens nach Liliane Juchli

- Körper** Wach sein & schlafen · Sich bewegen · Sich waschen & kleiden · Essen & trinken · Ausscheiden
- Vital** Körpertemperatur regulieren · Atmen
- Sicherheit** Sich sicher fühlen und verhalten · Raum & Zeit gestalten
- Sozial** Kommunizieren · Kind, Frau, Mann sein · Sinn finden

Merke: ATL sind die Grundlage jeder strukturierten Pflegeplanung.

05 13 AEDL

Das Modell von Monika Krohwinkel

Name	Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens
Kern	Erweitert die ATL um soziale Beziehungen und existenzielle Erfahrungen
Beispiel	„Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können“
Ziel	Ganzheitliche, fördernde Prozesspflege

Merke: AEDL betont das Existenzielle, ATL eher das Funktionelle.

06 10-R-Regel

Sichere Medikamentengabe

1-5	Richtiger Patient · Medikament · Dosierung · Applikationsform · Zeitpunkt
6-10	Richtige Dokumentation · Wirkung · Aufklärung · Haltbarkeit · Entsorgung

Merke: Im Zweifel immer nachfragen – nie raten.

07 Prophylaxen

Die Klassiker der Grundpflege

Dekubitus	Bewegungsförderung, Mikrolagerung, Hautpflege, Braden-Skala
Pneumonie	Atemübungen, Mobilisation, ausreichend trinken
Thrombose	MTS, Bewegung, Hochlagern, ggf. Heparin nach Anordnung
Sturz	Umgebung sichern, Hilfsmittel, Sturzrisiko einschätzen
Kontraktur	Lagern in Funktionsstellung, Bewegungsübungen

Merke: Jede Prophylaxe braucht eine Indikation und Dokumentation.

08 Dekubitus

Die 4 Feinde der Haut

Druck	Anhaltender Auflagedruck über Knochenvorsprüngen
Zeit	Je länger der Druck, desto höher das Risiko
Reibung	Scherkräfte beim Bewegen und Lagern
Feuchtigkeit	Mazeration durch Schweiß, Urin, Wundsekret

Merke: Risiko einschätzen mit Braden- oder Norton-Skala.

09 SBAR

Strukturierte Übergabe

S	Situation – Wer? Was ist das aktuelle Problem?
B	Background – Vorgeschichte, Diagnosen
A	Assessment – deine pflegerische Einschätzung
R	Recommendation – konkreter Vorschlag oder Bitte

Merke: Klare Übergabe = Patientensicherheit.

10 SOAP

Klare Pflegedokumentation

S	Subjektiv – Angaben und Empfinden des Patienten
O	Objektiv – Messwerte, Beobachtungen, Befunde
A	Assessment – fachliche Beurteilung
P	Plan – weiteres pflegerisches Vorgehen

Merke: Sachlich, wertfrei und nachvollziehbar dokumentieren.

11 ABCDE

Strukturierte Notfalleinschätzung

A	Airway – Atemweg frei?
B	Breathing – Frequenz, Tiefe, SpO ₂
C	Circulation – Puls, Blutdruck, Rekapillarisation
D	Disability – Bewusstsein (GCS), Pupillen, Blutzucker
E	Exposure – Entkleiden, Wärmeerhalt, Body-Check

Merke: Erst stabilisieren, dann weiter.

12 5 Momente

WHO-Händedesinfektion

1	Vor Patientenkontakt
2	Vor aseptischer Tätigkeit
3	Nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten
4	Nach Patientenkontakt
5	Nach Kontakt mit der Patientenumgebung

Merke: Handschuhe ersetzen die Händedesinfektion nicht.

**Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.**

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de